

# Chapitre 1

## Panorama de la protection sociale

F. Candau (UPPA-TREE)

# Les politiques sociales, une définition

---

- Les politiques sociales prennent en charge une **baisse de revenus** ou une **hausse de dépenses** liées à des risques socio-économiques, sanitaires, ou à des événements du cycle de vie (chômage, maladie, vieillesse).
- La prise en charge repose sur un principe de **solidarité**, intragénérationnelle (les actifs en emploi financent les prestations chômage) ou intergénérationnelle (des actifs vers les retraités).

# Dans la presse

---

Ces dépenses font débat, dans un sens et dans l'autre.

- « Crise budgétaire : 56 % des Français veulent couper dans les aides sociales » (*JDD*, avril 2025)
- « Aides sociales : ces milliards d'euros que les Français ne réclament pas » (*franceinfo*, octobre 2022)
- « Inégalités, redistribution, pouvoir d'achat... Le modèle social français est efficace, mais coûteux, selon l'Insee » (*franceinfo*, avril 2026)
- « Prestations sociales : en France, la redistribution permet de diminuer d'un tiers le nombre de personnes pauvres » (*franceinfo*, août 2024)

# Les six risques débattus dans les médias (1/2)

---

Les comptes de la protection sociale distinguent six catégories de risques.

- **Santé** (maladie, invalidité, accidents du travail)
  - « Le déficit de l'Assurance-maladie pourrait atteindre 41 milliards d'euros en 2030 » (*franceinfo*, juin 2025)
  - « Hôpital : de nombreux services d'urgences contraints de fermer faute de soignants » (*franceinfo*, août 2024)
  - « Arrêts maladie : la suspicion plutôt que la prévention » (*Politis*, avril 2026)
- **Vieillesse-survie** (retraites, minimum vieillesse, dépendance, réversion)
  - « Privé sacrifié, fonctionnaires choyés : le véritable scandale des retraites » (*Le Figaro*)
  - « En Allemagne, la retraite par capitalisation a produit plus de pauvreté que de capital » (*Alternatives économiques*, mars 2024)
- **Maternité-famille**
  - « Natalité : le nombre de bébés en France est le plus bas depuis 1945 » (*franceinfo*, janvier 2026)
  - « Non, il n'y a pas 42 % d'allocations familiales versées aux étrangers » (*franceinfo*, Désintox)

## Les six risques débattus dans les médias (2/2)

---

- **Emploi** (indemnisation du chômage, préretraites, insertion)
  - « L'exécutif se prépare à durcir à nouveau les règles de l'assurance-chômage » (*Public Sénat*, février 2024)
  - « Les demandeurs d'emploi sont les boucs émissaires du gouvernement » (*Public Sénat*, mai 2024)
- **Logement**
  - « Logement social : "C'est inédit, on n'a jamais eu autant de demandeurs en France" » (*franceinfo*, octobre 2023)
  - « La réforme des APL a fait plus de perdants que de gagnants, selon un rapport du Sénat » (*Public Sénat*, novembre 2021)
- **Pauvreté et exclusion sociale** (dont le RSA)
  - « "Arrêter l'assistanat" : les députés LR réclament une commission d'enquête sur les aides sociales » (*JDD*, 2025)
  - « Plus d'un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le touchent pas » (*franceinfo*, 2024)

# Périmètre, définition, plan

---

- **Périmètre de ce cours** : plus large que la Sécurité sociale (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille, autonomie depuis 2020). S'y ajoutent l'assurance chômage, les aides de l'État et des collectivités, les mutuelles.
- Plus étroit que l'État providence, dont sont exclues ici la législation du travail, la fiscalité et l'éducation.
- Ce périmètre est celui des **assurances sociales**, celles dont la loi rend l'affiliation obligatoire et dont le financement ne dépend pas du risque propre de chacun. L'assurance privée est facultative et tarifée selon le risque.
- **Plan** : les trois types de systèmes d'assurance et les deux logiques de couverture, puis le système français, ses branches et ses dépenses, enfin la dynamique démographique et trois mécanismes communs à toutes les branches.

# Trois types de systèmes d'assurance

---

Il existe trois types de systèmes d'assurance.

- Un système **public et obligatoire** (France, assurance maladie de base).
- Un système **privé mais obligatoire**, la loi imposant de s'assurer auprès de compagnies en concurrence (Suisse, Pays-Bas).
- Un système **privé et facultatif**, que l'État soutient en exonérant d'impôt et de cotisations les contrats souscrits (États-Unis, couverture maladie des salariés).

Aucun pays ne relève d'un seul type. En France, l'assurance maladie de base est publique et obligatoire, la complémentaire santé des salariés est privée et obligatoire depuis 2013, et l'État la soutient en exonérant de cotisations sociales la part payée par l'employeur.

# Le modèle contributif (Bismarck)

---

- Deux “systèmes” sont traditionnellement comparés.
- Dans un système contributif, aussi dit Bismarkien, la protection sociale est une assurance liée au travail, qui couvre ceux qui exercent une activité et cotisent, ainsi que leur famille. Le droit à la prestation naît de la cotisation.
- Son objet est de remplacer un revenu d’activité perdu => la prestation est proportionnelle au salaire antérieur. On fait perdurer les inégalités salariales.
- La prestation est un “salaire différé”, et non un transfert de la collectivité.
- La gestion revient à des caisses distinctes de l’État, où siègent employeurs et salariés (assurances sociales allemandes des années 1880, lois françaises de 1898-1930, Sécurité sociale de 1945).

# Le modèle universel (Beveridge)

---

- Le modèle universel, dit beveridgien, fait de la protection sociale un droit attaché à la personne, indépendamment de son activité, et le droit à la prestation naît de l'appartenance à la collectivité.
- Son objet est de garantir à chacun un socle de ressources et l'accès aux soins, si bien que la prestation est **forfaitaire**, la même pour tous quel qu'ait été le revenu antérieur.
- Financement par l'impôt.
- La gestion revient à l'État (rapport Beveridge de 1942, pays nordiques).

# Quatre dimensions pour situer un système

|                  | Contributif (Bismarck)       | Universel (Beveridge)    |
|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Accès aux droits | Emploi et cotisation         | Résidence, citoyenneté   |
| Prestations      | Proportionnelles au salaire  | Forfaitaires             |
| Financement      | Cotisations sur les salaires | Impôt                    |
| Gestion          | Caisses, partenaires sociaux | Administration de l'État |
| Redistribution   | Horizontale, entre risques   | Verticale, entre revenus |

- Esping-Andersen (1990) classe les systèmes selon le degré d'indépendance à l'égard du marché qu'ils procurent, la **démarchandisation**, et distingue trois régimes, **libéral**, **social-démocrate** et **conservateur-corporatiste**.

# L'organisation française

---

Le système français s'organise en régimes, branches et caisses.

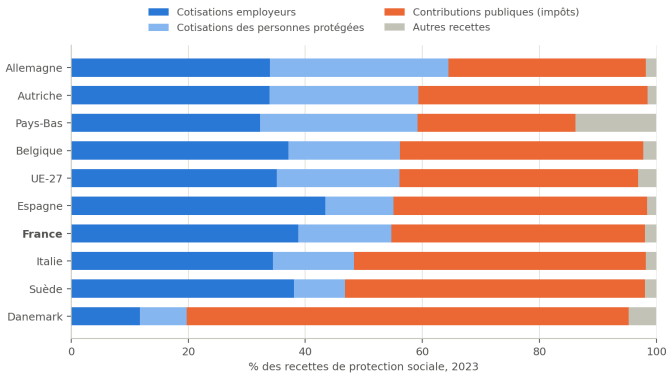
- Il existe un grand nombre de **régimes** de sécurité sociale. Le **régime général** couvre les salariés du secteur privé et verse 40-45 % des prestations.
- Le régime général est structuré en cinq **branches**, maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles, autonomie depuis 2020, chacune gérée par une caisse nationale tenue d'assurer son équilibre financier (Cnam, Cnaf). L'idée initiale était de séparer la gestion des risques.
- Le **chômage** et l'insertion sont gérés hors Sécurité sociale.

# Un financement qui passe de plus en plus par les impôts

---

- **Cotisations** : assises sur les salaires, elles ouvrent des droits. C'est le financement d'origine.
- **Fiscalisation** : depuis les années 1980-1990, recours croissant à l'impôt (CSG en 1991, CRDS en 1996, impôts et taxes affectés aux branches).
- Part des cotisations dans les recettes : **80 % en 1990, 55 % en 2023.**
- Effets sur le coût du travail et l'emploi : chapitre 8.

# La part des cotisations en Europe



Partie d'un financement aussi contributif que celui de l'Allemagne (64 % de cotisations), la France (55 %) est désormais à la moyenne européenne ; le Danemark est à 20 %. Source : Eurostat, ESSPROS.

# Les branches selon la grille

Partie du modèle contributif en 1945, la France a ouvert plusieurs branches sur la résidence et fiscalisé une partie de son financement. Sa position dans la grille dépend de la branche.

| Branche              | Ouverture des droits         | Règle principale                                      | Financement                                                 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maladie              | Résidence depuis 2016        | Tarif de convention, ticket modérateur                | cotis. employeurs 38 %, CSG 23 %, impôts 29 %               |
| Retraites            | Cotisation, carrière         | 64 ans, 43 annuités, 25 meilleures années             | cotis. employeurs 32 %, salariés 22 %, impôts 10 %, CSG 7 % |
| Chômage              | 6 mois sur 24                | ≈ 57 % du brut, 18 mois au plus avant 55 ans          | contributions employeurs 60 %, CSG 38 %                     |
| Famille              | Résidence, enfants           | Dès le 2 <sup>e</sup> enfant, modulées depuis 2015    | cotis. employeurs 63 %, CSG 24 %, impôts 10 %               |
| Accidents du travail | Emploi salarié               | Réparation forfaitaire, cotisation selon sinistralité | cotis. employeurs 92 %                                      |
| Minima sociaux       | Résidence, ressources        | Prestation différentielle                             | impôt                                                       |
| Autonomie            | Résidence, perte d'autonomie | Plan d'aide, participation selon revenu               | CSG 89 %, impôts 11 %                                       |

# Un système hybride

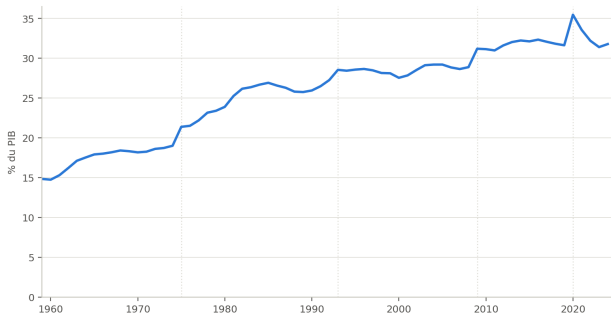
---

La France a commencé contributive et s'est universalisée sans jamais changer de modèle d'ensemble.

- **Dualisation** (Palier, 2005) : une sphère d'assurance contributive pour les risques du travail, une sphère universelle et fiscalisée pour la maladie, la famille et la pauvreté.
- **Hybridation** (Elbaum, 2011) : la France ne relève ni d'un modèle ni de l'autre, branche par branche.
- Le financement, proportionnel aux salaires au début des années 1990, est devenu progressif sous l'effet de la CSG et des allègements sur les bas salaires (Zemmour, 2015).
- L'hybridation n'est pas propre à la France, mais elle y est marquée : point de départ plus contributif, point d'arrivée plus fiscalisé.

# Un tiers du PIB

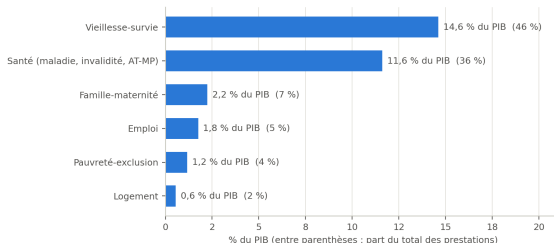
- La part des prestations dans le PIB a plus que doublé, de **14,8 % en 1959** à **31,8 % en 2024**.



Traits verticaux : années de contraction du PIB (1975, 1993, 2009, 2020). Sources : DREES, comptes de la protection sociale ; INSEE.

# Par habitant et par risque

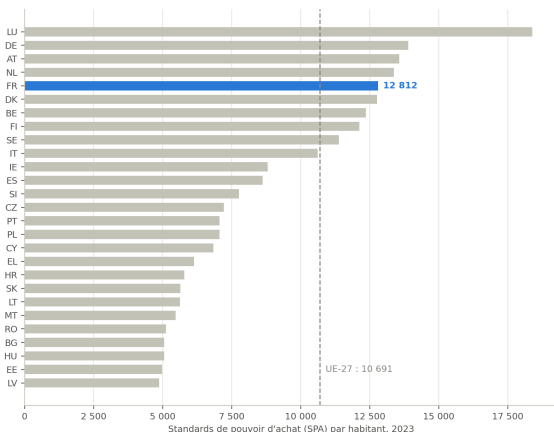
- En 2024, environ **13 600 euros par habitant**, dont 6 220 euros pour la seule vieillesse-survie.
- Vieillesse-survie (46 %) et santé (36 %) concentrent plus de 80 % des prestations.



Source : Eurostat, ESSPROS.

# Une exception française ?

- La France est 5<sup>e</sup> sur 27 par habitant, mais la première de l'Union en % du PIB.



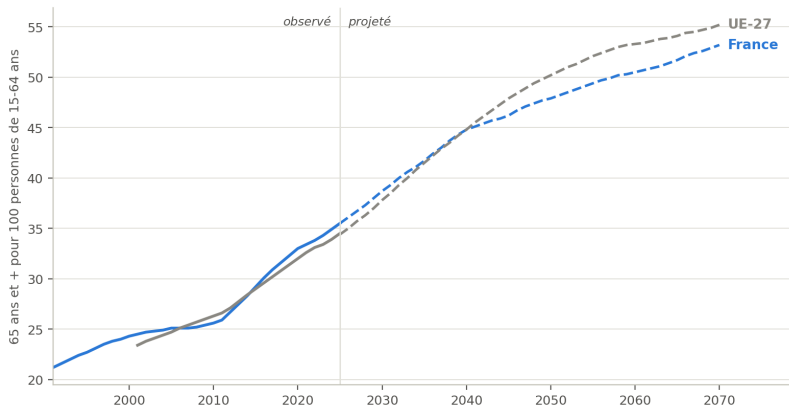
# Le ratio de dépendance des personnes âgées

---

$$\text{ratio de dépendance des personnes âgées} = \frac{\text{personnes de 65 ans et plus}}{\text{personnes de 15 à 64 ans}} \times 100$$

- Il mesure approximativement le nombre de personnes que chaque centaine d'actifs potentiels doit financer.
- Ce ratio a fortement augmenté (figure suivante).
- La France comptait environ cinq personnes d'âge actif par personne âgée en 1990, et elle en comptera moins de deux en 2070.

# Ratio de dépendance des 65 ans et plus



En 2025, dernière année observée, la France compte 36 personnes âgées pour 100 actifs. Source : Eurostat.

# Lire les projections

---

- Le vieillissement est général en Europe. La France y échappe un peu en fin de période, grâce à une fécondité longtemps plus élevée.
- **À 15 ans** : l'incertitude vient presque uniquement du solde migratoire.
- **À l'horizon 2070** : la fécondité devient l'hypothèse la plus sensible, devant les migrations et l'espérance de vie.
- **L'ordre de grandeur reste robuste** : les personnes qui auront 65 ans en 2050 sont déjà nées.
- Ce fait structure tout le cours, des retraites (chapitre 3) à la santé et la dépendance (chapitre 4), jusqu'au financement (chapitre 8).

# Aléa moral et sélection adverse

---

Trois mécanismes reviennent dans chaque chapitre.

- **Aléa moral** : la couverture d'un risque pourrait modifier le comportement de l'assuré, qui n'en supporte plus le coût.
  - Un patient remboursé consomme-t-il plus de soins ? (chap. 4)
  - Un chômeur indemnisé cherche-t-il moins activement ? (chap. 6)
- **Sélection adverse** : l'assuré connaît son risque mieux que l'assureur, qui tarife un risque moyen.
  - À ce tarif, les bons risques se retirent, le coût moyen monte, la prime suit.
  - L'affiliation obligatoire empêche ce retrait, première justification des systèmes obligatoires (rentes viagères chap. 3, maladie chap. 4, chômage chap. 6).

# La justice de la redistribution

---

- La protection sociale redistribue, des bien-portants vers les malades, des actifs vers les retraités, des hauts revenus vers les bas revenus.
- Jusqu'où doit aller cette redistribution ?
- Garantir un minimum, égaliser les chances au départ ou corriger les résultats à l'arrivée ?
- Compenser les inégalités non choisies (naissance, maladie) sans compenser celles qui résultent de choix ?
- Le chapitre 7 présente les théories qui répondent à ces questions, le chapitre 8 la répartition de la charge.

# Conclusion

---

- **Aucun modèle pur** : née contributive, la protection sociale française a ouvert l'accès aux droits par la résidence dans plusieurs branches et fiscalisé une partie de son financement.
- **Un tiers du PIB**, dominé par la vieillesse et la santé.
- Le vieillissement continuera d'en tirer les dépenses, la question du financement avec elles.
- Les chapitres suivants reprennent ces fils : l'histoire de cette construction, puis chaque branche avec ses tensions propres.

# Les ordres de grandeur à retenir

---

- Prestations de protection sociale : environ **un tiers du PIB** (31,8 % en 2024), contre 14,8 % en 1959, soit environ **13 600 euros par habitant**.
- **Vieillesse-survie (46 %) et santé (36 %)** concentrent plus de 80 % des prestations.
- La France est **au sommet de l'UE en % du PIB**, mais 5<sup>e</sup> par habitant.
- Part des cotisations dans les recettes : de **80 % en 1990 à 55 %** aujourd'hui.
- Ratio de dépendance des 65 ans et plus : d'environ **36 aujourd'hui à 53 en 2070**.

# Questions de cours

---

- ❶ Qu'est-ce qui distingue une assurance sociale d'une assurance privée ?
- ❷ Quels sont les trois types de systèmes d'assurance ? Donnez un exemple français de chacun.
- ❸ Distinguez solidarité intragénérationnelle et solidarité intergénérationnelle, avec un exemple de chacune.
- ❹ Comment se répartit la dépense de protection sociale française entre les grands risques ?
- ❺ Par quels mécanismes le vieillissement démographique pèse-t-il sur les dépenses sociales ?

# Question de réflexion

---

- ❶ La protection sociale française relève-t-elle encore d'un modèle contributif ?